JEU DE 52 CARTES + 2 JOKERS · ÉTUDIANTS IPA, MENTION MALADIE RÉNALE CHRONIQUE, DIALYSE, TRANSPLANTATION RÉNALE

Raisonnement clinique IPA · Maladie rénale chronique

Un jeu de 52 cartes pour la mention « Maladie rénale chronique, dialyse, transplantation rénale ». Chaque couleur correspond à une étape du raisonnement clinique, chaque valeur à une situation clinique suivie à travers un même patient. Chaque carte indique les compétences IPA qu'elle mobilise. Réunir les quatre cartes d'une valeur, c'est dérouler un raisonnement complet, du recueil des données à la coordination du parcours.

Les 4 couleurs = 4 étapes

♥	**Cœur — Recueillir** Anamnèse, écoute, contexte de vie
♦	**Carreau — Repérer & hypothèses** Repérage, scores, hypothèses et drapeaux rouges
♣	**Trèfle — Vérifier** Examen clinique, examens complémentaires, diagnostics différentiels
♠	**Pique — Agir & suivre** Projet de soins, prévention, ETP, parcours et coordination

Les 13 valeurs = 13 situations

2	Repérage de la MRC
3	Néphroprotection et iatrogénie
4	Hyperkaliémie
5	Anémie de la MRC
6	Troubles minéraux et osseux
7	Nutrition et MRC
8	Choix du traitement de suppléance
9	Fistule artério-veineuse
10	Hémodialyse : surcharge hydrosodée
V	Dialyse péritonéale : péritonite
D	Greffe : observance
R	Greffe : prévention
A	Traitement conservateur du sujet âgé

Anatomie d'une carte

Vignette (situation du patient, qui évolue d'une couleur à l'autre) · **Question** posée au joueur · **Repères attendus**, lus uniquement par celui qui pose la question pour valider la réponse. Les repères ne sont pas exhaustifs : une argumentation pertinente non listée est valorisée.

Mode 1 · Le Carré clinique

3 à 6 joueurs · 45 à 60 min

1. Distribuer 6 cartes par joueur ; le reste forme la pioche.
2. À son tour, un joueur demande à un autre une carte précise pour avancer un carré (« le Trèfle de l'hyperkaliémie »).
3. Si l'autre la possède, il lit la vignette et la question ; le demandeur répond. Réponse validée au regard des repères → il prend la carte et rejoue. Sinon, ou si la carte n'est pas en jeu, il pioche et la main passe.
4. Carré complet : le joueur le pose et présente en 2 minutes une **synthèse orale** du raisonnement (recueil → hypothèses → vérification → action) : **4 points**. +1 point s'il le relie à une autre thématique (néphroprotection et hyperkaliémie, greffe et prévention...).
5. Fin de partie quand la pioche est vide : le plus de points l'emporte.

Les jokers

Drapeau rouge et **Leadership & recherche** remplacent une carte manquante d'un carré, à condition de relever le défi inscrit dessus.

Mode 2 · Le Fil rouge

Travaux dirigés · groupes de 4 à 8 · 20 min par cas

L'animateur extrait les 4 cartes d'une situation et les révèle dans l'ordre ♥ ♦ ♣ ♠. Le groupe raisonne à voix haute à chaque étape avant de découvrir la suivante, puis compare avec les repères.

Mode 3 · Le Tirage éclair

Révision en binôme · 10 à 15 min

Mélanger, tirer une carte, lire la vignette et la question ; le partenaire répond en 1 minute. Comparer aux repères, puis inverser les rôles.

Pistes de débriefing

- Hiérarchisation des hypothèses, drapeaux rouges
- Biais cognitifs : ancrage, fermeture prématurée
- Place du patient : préférences, littératie, décision partagée
- Cadre d'exercice IPA : ce qui relève de l'IPA, de la concertation, de l'orientation

Impression : A4, recto verso (retournement bord long), échelle 100 %, papier 250 à 300 g/m² ; découper le long des repères de coupe. Pages impaires = faces, pages paires = dos.
Avertissement : contenus fondés sur les recommandations connues en octobre 2026 (HAS, sociétés savantes, référentiels de la mention), sans vérification en ligne carte par carte ; les cas sont illustratifs. Les conduites thérapeutiques s'entendent dans le cadre des protocoles et de la réglementation en vigueur. À vérifier et actualiser par l'équipe pédagogique avant usage.

MENTION MALADIE RÉNALE CHRONIQUE, DIALYSE, TRANSPLANTATION RÉNALE

Compétences et situations

La mention maladie rénale chronique, dialyse et transplantation rénale couvre le repérage et le suivi de la MRC, la néphroprotection, la gestion de ses complications, la préparation aux traitements de suppléance, le suivi en dialyse (hémodialyse, dialyse péritonéale), le suivi des patients transplantés et l'accompagnement du traitement conservateur.

Les 6 compétences IPA mobilisées

Code	Compétence	Où dans le jeu
C1	Évaluer l'état de santé de patients en relais de consultations médicales pour des pathologies identifiées	♥ ♦ ♣
C2	Définir et mettre en œuvre le projet de soins du patient à partir de l'évaluation globale de son état de santé	♣ ♠
C3	Concevoir et mettre en œuvre des actions de prévention et d'éducation thérapeutique	♦ ♠
C4	Organiser les parcours de soins et de santé en collaboration avec l'ensemble des acteurs concernés	♠
C5	Mettre en place et conduire des actions d'évaluation et d'amélioration des pratiques en exerçant un leadership clinique	Joker 2, repères ♠
C6	Rechercher, analyser et produire des données professionnelles et scientifiques	Joker 2, débriefing

Chaque carte porte en en-tête les compétences qu'elle mobilise en priorité. Les compétences C5 et C6 sont travaillées avec le joker « Leadership & recherche » et lors du débriefing.

Les 13 situations cliniques

2	**Repérage de la MRC** M. S., 62 ans, hypertendu et diabétique, vient pour un bilan annuel. Son albuminurie n'a jamais été dosée.
3	**Néphroprotection et iatrogénie** Mme N., 74 ans, MRC stade 3b (DFG 38), doit passer un scanner injecté. Elle prend de l'ibuprofène pour son arthrose.
4	**Hyperkaliémie** M. K., 70 ans, MRC stade 4, insuffisant cardiaque sous IEC et spironolactone. Kaliémie : 6,2 mmol/L.
5	**Anémie de la MRC** Mme A., 66 ans, MRC stade 4, se plaint d'essoufflement et d'une fatigue croissante.
6	**Troubles minéraux et osseux** M. P., 60 ans, MRC stade 4, se plaint de démangeaisons et de douleurs osseuses.
7	**Nutrition et MRC** Mme D., 69 ans, MRC stade 4, a lu qu'il fallait « manger moins de viande ». Elle a perdu 5 kg en 3 mois.
8	**Choix du traitement de suppléance** M. L., 58 ans, MRC stade 4 (DFG 18), travaille encore. Le néphrologue veut aborder les traitements de suppléance.
9	**Fistule artério-veineuse** Mme F., 65 ans, hémodialysée sur fistule depuis 2 ans, signale que « le frisson de la fistule est moins fort ».
10	**Hémodialyse : surcharge hydrosodée** M. B., 72 ans, hémodialysé 3 fois par semaine, arrive avec 4 kg de plus depuis la dernière séance.
V	**Dialyse péritonéale : péritonite** Mme K., 55 ans, en dialyse péritonéale à domicile, appelle : son liquide de drainage est trouble.
D	**Greffe : observance** Thomas, 23 ans, transplanté rénal à 18 ans, voit sa créatinine augmenter. Il fait ses études loin de chez ses parents.
R	**Greffe : prévention** Mme G., 60 ans, transplantée rénale depuis 10 ans, vient pour son suivi annuel.
A	**Traitement conservateur du sujet âgé** M. V., 87 ans, MRC stade 5 (DFG 11), insuffisant cardiaque, vit en EHPAD. Le néphrologue propose de discuter des options.

2 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Repérage de la MRC

Compétences IPA : C1

M. S., 62 ans, hypertendu et diabétique, vient pour un bilan annuel. Son albuminurie n'a jamais été dosée.

? Quelles données recueillez-vous pour évaluer son risque rénal ?

REPÈRES ATTENDUS

- Facteurs de risque : diabète, HTA, maladie cardiovasculaire, obésité, antécédents familiaux
- Médicaments néphrotoxiques : AINS, lithium, IPP au long cours
- Antécédents : insuffisance rénale aiguë, lithiase, infections urinaires
- Nycturie, œdèmes, urines mousseuses

Raisonnement clinique · IPA MRC

♥ 2

2 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Repérage de la MRC

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : M. S., 62 ans, hypertendu et diabétique, vient pour un bilan annuel. Son albuminurie n'a jamais été dosée.

DFG (CKD-EPI) : 52 mL/min/1,73 m². Ratio albuminurie/créatininurie : 45 mg/mmol.

? Comment classez-vous l'atteinte rénale ?

REPÈRES ATTENDUS

- MRC si anomalie persistante > 3 mois : DFG < 60 et/ou albuminurie
- Stade G3a (DFG 45–59)
- Albuminurie A3 (> 30 mg/mmol) : risque élevé
- Confirmation nécessaire à 3 mois

Raisonnement clinique · IPA MRC

♦ 2

2 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Repérage de la MRC

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : M. S., 62 ans, hypertendu et diabétique, vient pour un bilan annuel. Son albuminurie n'a jamais été dosée.

Le contrôle à 3 mois confirme les résultats.

? Quel bilan réalisez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Ionogramme, bicarbonates, calcium, phosphore, NFS
- Bandelette urinaire (hématurie ?)
- Échographie rénale et des voies urinaires
- HbA1c, bilan lipidique

Raisonnement clinique · IPA MRC

♣ 2

2 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Repérage de la MRC

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : M. S., 62 ans, hypertendu et diabétique, vient pour un bilan annuel. Son albuminurie n'a jamais été dosée.

MRC G3a A3, d'origine diabétique probable.

? Quel plan proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Néphroprotection : bloqueur du système rénine-angiotensine et iSGLT2, sur prescription
- PA cible souvent < 130/80 en cas d'albuminurie ; équilibre glycémique
- ETP : éviter AINS et automédication, adaptation des médicaments au DFG
- Avis néphrologique (albuminurie A3)
- Suivi DFG et albuminurie selon le stade

Raisonnement clinique · IPA MRC

♠ 2

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

3 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Néphroprotection et iatrogénie

Compétences IPA : C1

Mme N., 74 ans, MRC stade 3b (DFG 38), doit passer un scanner injecté. Elle prend de l'ibuprofène pour son arthrose.

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Tous les médicaments, automédication, phytothérapie
- Hydratation, diurétiques, IEC ou ARA2, metformine
- Antécédents d'insuffisance rénale aiguë
- Indication et urgence de l'examen injecté

Raisonnement clinique · IPA MRC

♥ 3

3 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Néphroprotection et iatrogénie

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : Mme N., 74 ans, MRC stade 3b (DFG 38), doit passer un scanner injecté. Elle prend de l'ibuprofène pour son arthrose.

Elle prend aussi metformine 1 g × 2 et un IEC.

? Quels risques identifiez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- AINS : risque d'insuffisance rénale aiguë, majoré avec IEC + diurétique
- Metformine : dose maximale 1 g/jour pour un DFG entre 30 et 44
- Produit de contraste iodé : risque selon le DFG et l'hydratation
- Nombreux médicaments à adapter au DFG

Raisonnement clinique · IPA MRC

♦ 3

3 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Néphroprotection et iatrogénie

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : Mme N., 74 ans, MRC stade 3b (DFG 38), doit passer un scanner injecté. Elle prend de l'ibuprofène pour son arthrose.

DFG à 38, stable.

? Que vérifiez-vous avant l'examen ?

REPÈRES ATTENDUS

- Créatinine récente selon le protocole
- Hydratation adaptée avant et après
- Suspension de la metformine autour de l'injection, selon protocole
- Balance bénéfice-risque discutée avec le radiologue

Raisonnement clinique · IPA MRC

♣ 3

3 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Néphroprotection et iatrogénie

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : Mme N., 74 ans, MRC stade 3b (DFG 38), doit passer un scanner injecté. Elle prend de l'ibuprofène pour son arthrose.

L'examen est maintenu.

? Quel plan de néphroprotection proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Arrêt définitif des AINS ; paracétamol, mesures non médicamenteuses
- Metformine adaptée au DFG avec le prescripteur
- Créatinine de contrôle à 48–72 h
- ETP : carte « mes reins », informer pharmacien et soignants
- Consignes en cas de déshydratation (suspension de certains médicaments)

Raisonnement clinique · IPA MRC

♠ 3

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

4 ♥ CŒUR · RECUEILLIR

Hyperkaliémie

Compétences IPA : C1

M. K., 70 ans, MRC stade 4, insuffisant cardiaque sous IEC et spironolactone. Kaliémie : 6,2 mmol/L.

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Faiblesse musculaire, paresthésies, palpitations, malaise
- Médicaments hyperkaliémiants : IEC, ARA2, antialdostérone, AINS, triméthoprime
- Alimentation : sels de régime, fruits secs, jus
- Déshydratation, diarrhée
- Conditions du prélèvement (hémolyse ?)

Raisonnement clinique · IPA MRC

4 ♠

4 ♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Hyperkaliémie

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : M. K., 70 ans, MRC stade 4, insuffisant cardiaque sous IEC et spironolactone. Kaliémie : 6,2 mmol/L.

Asymptomatique. Il utilise un sel de régime « sans sodium ».

? Comment analysez-vous la situation ?

REPÈRES ATTENDUS

- Hyperkaliémie potentiellement grave (6,0 à 6,5 mmol/L)
- Causes : sel de substitution riche en potassium, double blocage, MRC
- Fausse hyperkaliémie par hémolyse à éliminer
- La gravité dépend de l'ECG et du niveau de kaliémie

Raisonnement clinique · IPA MRC

4 ♦

4 ♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Hyperkaliémie

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : M. K., 70 ans, MRC stade 4, insuffisant cardiaque sous IEC et spironolactone. Kaliémie : 6,2 mmol/L.

Vous faites réaliser un ECG.

? Que recherchez-vous ? Quelle urgence ?

REPÈRES ATTENDUS

- Ondes T pointues, élargissement du QRS, troubles conductifs
- Contrôle immédiat de la kaliémie, bicarbonates, créatinine
- Anomalie ECG ou kaliémie ≥ 6,5 mmol/L → urgence hospitalière
- Évaluation de la volémie

Raisonnement clinique · IPA MRC

4 ♣

4 ♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Hyperkaliémie

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : M. K., 70 ans, MRC stade 4, insuffisant cardiaque sous IEC et spironolactone. Kaliémie : 6,2 mmol/L.

ECG normal, kaliémie contrôlée à 6,0 mmol/L.

? Quelle conduite à tenir ?

REPÈRES ATTENDUS

- Avis médical le jour même : adaptation des traitements, chélateur du potassium
- Arrêt du sel de régime ; conseils diététiques ciblés
- Correction d'une acidose selon prescription
- Contrôle biologique sous 48–72 h
- ETP : signes d'alerte, médicaments à éviter

Raisonnement clinique · IPA MRC

4 ♥

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

5 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Anémie de la MRC

Compétences IPA : C1

Mme A., 66 ans, MRC stade 4, se plaint d'essoufflement et d'une fatigue croissante.

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Fatigue, dyspnée, tolérance à l'effort, douleur thoracique
- Saignements digestifs ou gynécologiques, antiagrégants
- Alimentation, apports en fer
- Comorbidités cardiaques

Raisonnement clinique · IPA MRC

5 ♥

5 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Anémie de la MRC

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : Mme A., 66 ans, MRC stade 4, se plaint d'essoufflement et d'une fatigue croissante.

Hb 9,4 g/dL, anémie normocytaire.

? Quelles hypothèses formulez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Anémie de la MRC (déficit en érythropoïétine)
- Carence martiale souvent associée
- Autres causes : saignement, carence en B12 ou folates, inflammation, hémopathie
- Retentissement cardiaque

Raisonnement clinique · IPA MRC

5 ♦

5 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Anémie de la MRC

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : Mme A., 66 ans, MRC stade 4, se plaint d'essoufflement et d'une fatigue croissante.

Vous complétez le bilan.

? Quels examens réalisez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Ferritine, coefficient de saturation de la transferrine (CST)
- Réticulocytes, B12, folates, CRP
- Recherche d'un saignement digestif selon le contexte
- Carence martiale dans la MRC : ferritine < 100 µg/L et/ou CST < 20 %

Raisonnement clinique · IPA MRC

5 ♣

5 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Anémie de la MRC

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : Mme A., 66 ans, MRC stade 4, se plaint d'essoufflement et d'une fatigue croissante.

Ferritine 60 µg/L, CST 15 %.

? Quelle prise en charge ?

REPÈRES ATTENDUS

- Supplémentation martiale orale ou IV, sur prescription
- Agent stimulant l'érythropoïèse si l'anémie persiste, selon le néphrologue
- Cible d'Hb autour de 10–11,5 g/dL, sans normalisation complète
- Surveillance : Hb, PA, ferritine
- ETP : traitements et signes d'alerte

Raisonnement clinique · IPA MRC

5 ♠

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

6 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Troubles minéraux et osseux

Compétences IPA : C1

> *M. P., 60 ans, MRC stade 4, se plaint de démangeaisons et de douleurs osseuses.*

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Prurit : intensité, retentissement sur le sommeil
- Douleurs osseuses, fractures
- Alimentation : produits industriels, charcuterie, sodas (phosphates)
- Chélateurs, vitamine D, observance

Raisonnement clinique · IPA MRC

♥ 9

6 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Troubles minéraux et osseux

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : M. P., 60 ans, MRC stade 4, se plaint de démangeaisons et de douleurs osseuses.

> *Phosphore 1,9 mmol/L, calcium normal, PTH à 4 fois la normale.*

? Comment interprétez-vous ce bilan ?

REPÈRES ATTENDUS

- Troubles minéraux et osseux de la MRC
- Hyperphosphatémie
- Hyperparathyroïdie secondaire
- Risque cardiovasculaire (calcifications) et osseux

Raisonnement clinique · IPA MRC

♦ 9

6 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Troubles minéraux et osseux

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : M. P., 60 ans, MRC stade 4, se plaint de démangeaisons et de douleurs osseuses.

> *Vous complétez l'évaluation.*

? Quels examens réalisez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- 25-OH vitamine D
- Phosphatases alcalines
- Bicarbonates
- Évaluation diététique des apports en phosphore

Raisonnement clinique · IPA MRC

♣ 9

6 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Troubles minéraux et osseux

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : M. P., 60 ans, MRC stade 4, se plaint de démangeaisons et de douleurs osseuses.

> *M. P. consomme beaucoup de produits industriels.*

? Quel plan proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- ETP diététique : repérer les additifs phosphatés sur les étiquettes
- Chélateurs du phosphore pendant les repas, sur prescription
- Correction de la vitamine D, traitement de l'hyperparathyroïdie selon le néphrologue
- Prise en charge du prurit
- Suivi biologique régulier

Raisonnement clinique · IPA MRC

♠ 9

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

7 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Nutrition et MRC

Compétences IPA : C1

Mme D., 69 ans, MRC stade 4, a lu qu'il fallait « manger moins de viande ». Elle a perdu 5 kg en 3 mois.

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Poids, IMC, évolution
- Apports en protéines, sel, potassium
- Appétit, nausées, goût métallique (urémie)
- Restrictions qu'elle s'impose, sources d'information

Raisonnement clinique · IPA MRC

7 ♥

7 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Nutrition et MRC

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : Mme D., 69 ans, MRC stade 4, a lu qu'il fallait « manger moins de viande ». Elle a perdu 5 kg en 3 mois.

Albuminémie 33 g/L, bicarbonates 18 mmol/L.

? Quels problèmes identifiez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Risque de dénutrition par restriction excessive
- Acidose métabolique (bicarbonates < 22) : favorise le catabolisme
- Apports protéiques modérés (environ 0,6 à 0,8 g/kg/j selon prescription), jamais au prix d'une dénutrition
- Symptômes urémiques possibles

Raisonnement clinique · IPA MRC

7 ♦

7 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Nutrition et MRC

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : Mme D., 69 ans, MRC stade 4, a lu qu'il fallait « manger moins de viande ». Elle a perdu 5 kg en 3 mois.

Elle se sent fatiguée.

? Quelles évaluations complètent votre analyse ?

REPÈRES ATTENDUS

- Évaluation diététique, force musculaire
- Urée, créatinine, ionogramme
- Symptômes urémiques
- Activité physique

Raisonnement clinique · IPA MRC

7 ♣

7 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Nutrition et MRC

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : Mme D., 69 ans, MRC stade 4, a lu qu'il fallait « manger moins de viande ». Elle a perdu 5 kg en 3 mois.

Elle veut « bien faire ».

? Quel plan proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Diététicien spécialisé : protéines adaptées, sel < 6 g/j, potassium si besoin
- Bicarbonate de sodium sur prescription
- Information fiable, programme d'ETP rénale
- Activité physique adaptée
- Suivi du poids et de l'albuminémie

Raisonnement clinique · IPA MRC

7 ♠

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

8 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Choix du traitement de suppléance

Compétences IPA : C1

M. L., 58 ans, MRC stade 4 (DFG 18), travaille encore. Le néphrologue veut aborder les traitements de suppléance.

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Connaissances et représentations sur la dialyse et la greffe
- Travail, logement, voyages, loisirs
- Entourage, donneur vivant potentiel
- Souhait d'autonomie (dialyse à domicile, autodialyse)
- Craintes et priorités

8 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Choix du traitement de suppléance

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : M. L., 58 ans, MRC stade 4 (DFG 18), travaille encore. Le néphrologue veut aborder les traitements de suppléance.

Il dit : « La dialyse, c'est la fin de ma vie. »

? Quels besoins identifiez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Information complète et neutre sur toutes les options
- Peurs à explorer, soutien
- Greffe préemptive à évaluer
- Temps de décision partagée

8 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Choix du traitement de suppléance

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : M. L., 58 ans, MRC stade 4 (DFG 18), travaille encore. Le néphrologue veut aborder les traitements de suppléance.

Vous préparez la décision.

? Quelles évaluations sont nécessaires ?

REPÈRES ATTENDUS

- Bilan prégreffe selon le néphrologue
- Capital veineux à préserver
- Faisabilité de la dialyse à domicile
- Vitesse de déclin du DFG

8 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Choix du traitement de suppléance

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : M. L., 58 ans, MRC stade 4 (DFG 18), travaille encore. Le néphrologue veut aborder les traitements de suppléance.

Il hésite entre dialyse péritonéale et greffe préemptive.

? Comment l'accompagnez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Programme d'information prédialyse, rencontre de patients-ressources
- Outils d'aide à la décision, décision partagée
- Préservation du capital veineux (bras de la future fistule)
- Coordination avec l'équipe de greffe ; information sur le don du vivant
- Anticiper l'abord de dialyse pour éviter un démarrage en urgence

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

9 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Fistule artério-veineuse

Compétences IPA : C1

Mme F., 65 ans, hémodialysée sur fistule depuis 2 ans, signale que « le frisson de la fistule est moins fort ».

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Thrill et souffle : changement récent
- Dernières séances : ponctions difficiles, pressions, saignement prolongé
- Douleur, œdème, rougeur du bras
- Hypotensions, compression du bras la nuit

Raisonnement clinique · IPA MRC

♥ 6

9 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Fistule artério-veineuse

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : Mme F., 65 ans, hémodialysée sur fistule depuis 2 ans, signale que « le frisson de la fistule est moins fort ».

Thrill diminué ; saignement prolongé après le retrait des aiguilles.

? Quelle hypothèse ?

REPÈRES ATTENDUS

- Sténose de la fistule probable
- Risque de thrombose de l'abord
- Infection à éliminer si signes locaux
- Urgence relative : préserver l'abord

Raisonnement clinique · IPA MRC

♦ 6

9 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Fistule artério-veineuse

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : Mme F., 65 ans, hémodialysée sur fistule depuis 2 ans, signale que « le frisson de la fistule est moins fort ».

Pas de signe infectieux.

? Quels examens ?

REPÈRES ATTENDUS

- Examen clinique (thrill, souffle, test d'élévation du bras)
- Mesure du débit, écho-doppler
- Données de dialyse : pressions veineuses, recirculation, Kt/V
- Avis néphrologue ou chirurgien vasculaire

Raisonnement clinique · IPA MRC

♣ 6

9 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Fistule artério-veineuse

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : Mme F., 65 ans, hémodialysée sur fistule depuis 2 ans, signale que « le frisson de la fistule est moins fort ».

Une sténose est confirmée.

? Quelle conduite et quelle éducation ?

REPÈRES ATTENDUS

- Angioplastie programmée par l'équipe
- ETP : vérifier le thrill chaque jour, aucune compression (montre, sac, sommeil)
- Ni PA ni prise de sang sur le bras de la fistule
- Hygiène du bras avant ponction
- Disparition du thrill = appel immédiat

Raisonnement clinique · IPA MRC

♠ 6

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

10 ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Hémodialyse : surcharge hydrosodée

Compétences IPA : C1

M. B., 72 ans, hémodialysé 3 fois par semaine, arrive avec 4 kg de plus depuis la dernière séance.

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Prise de poids interdialytique, poids sec
- Dyspnée, orthopnée, œdèmes
- Apports en eau et en sel, soif
- Diurèse résiduelle
- PA, crampes ou hypotensions en séance

Raisonnement clinique · IPA MRC

10 ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Hémodialyse : surcharge hydrosodée

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : M. B., 72 ans, hémodialysé 3 fois par semaine, arrive avec 4 kg de plus depuis la dernière séance.

Orthopnée, œdèmes des chevilles, PA 170/95.

? Comment analysez-vous la situation ?

REPÈRES ATTENDUS

- Surcharge hydrosodée
- Prise de poids interdialytique excessive (souvent > 4 % du poids sec)
- Risque d'œdème pulmonaire
- Poids sec à réévaluer

Raisonnement clinique · IPA MRC

10 ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Hémodialyse : surcharge hydrosodée

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : M. B., 72 ans, hémodialysé 3 fois par semaine, arrive avec 4 kg de plus depuis la dernière séance.

SpO_2 93 %.

? Quelles évaluations réalisez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Auscultation pulmonaire, radiographie selon le contexte
- Kaliémie avant séance
- Évaluation du poids sec (clinique, bio-impédance)
- Analyse des apports en sel et en liquides

Raisonnement clinique · IPA MRC

10 ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Hémodialyse : surcharge hydrosodée

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : M. B., 72 ans, hémodialysé 3 fois par semaine, arrive avec 4 kg de plus depuis la dernière séance.

Il dit avoir « toujours soif ».

? Quel plan proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Ajustement de l'ultrafiltration et du poids sec avec le néphrologue
- Réduire le sel, moteur de la soif
- Astuces : glaçons, petites quantités, boissons comptées
- ETP : carnet de poids, objectifs réalistes
- Dyspnée de repos = orientation urgente

Raisonnement clinique · IPA MRC

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Dialyse péritonéale : péritonite

Compétences IPA : C1

Mme K., 55 ans, en dialyse péritonéale à domicile, appelle : son liquide de drainage est trouble.

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Aspect du dialysat, douleurs abdominales, fièvre
- Faute d'asepsie, déconnexion accidentelle
- Orifice du cathéter : rougeur, écoulement
- Diarrhée, constipation

Raisonnement clinique · IPA MRC

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Dialyse péritonéale : péritonite

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : Mme K., 55 ans, en dialyse péritonéale à domicile, appelle : son liquide de drainage est trouble.

Douleurs abdominales diffuses, 38,2 °C.

? Quelle est votre hypothèse ?

REPÈRES ATTENDUS

- Péritonite liée à la dialyse péritonéale
- Urgence : prise en charge le jour même
- Origine : contamination lors des échanges, orifice, digestive
- Risque d'échec de la technique

Raisonnement clinique · IPA MRC

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Dialyse péritonéale : péritonite

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : Mme K., 55 ans, en dialyse péritonéale à domicile, appelle : son liquide de drainage est trouble.

Elle se rend au centre de dialyse.

? Quels examens ?

REPÈRES ATTENDUS

- Dialysat : leucocytes > 100/mm³ dont > 50 % de polynucléaires
- Examen direct et culture du dialysat
- Prélèvement de l'orifice si écoulement
- NFS, CRP, hémocultures si signes systémiques

Raisonnement clinique · IPA MRC

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Dialyse péritonéale : péritonite

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : Mme K., 55 ans, en dialyse péritonéale à domicile, appelle : son liquide de drainage est trouble.

Péritonite confirmée.

? Quelle prise en charge et quelle prévention ?

REPÈRES ATTENDUS

- Antibiothérapie intrapéritonéale selon protocole
- Analyse des causes : réévaluation de la technique, reformation
- ETP : hygiène des mains, masque, soin de l'orifice
- Surveillance de l'aspect du dialysat
- Suivi du taux de péritonites du centre (indicateur qualité)

Raisonnement clinique · IPA MRC

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

D ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Greffe : observance

Compétences IPA : C1

> *Thomas, 23 ans, transplanté rénal à 18 ans, voit sa créatinine augmenter. Il fait ses études loin de chez ses parents.*

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Prise des immunosuppresseurs : horaires, oublis, arrêts
- Mode de vie : horaires, sorties, alcool, substances
- Effets indésirables vécus (tremblements, acné, poids)
- Transition pédiatrie-adulte, soutien
- Représentations du greffon

Raisonnement clinique · IPA MRC

♥ D

D ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Greffe : observance

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : Thomas, 23 ans, transplanté rénal à 18 ans, voit sa créatinine augmenter. Il fait ses études loin de chez ses parents.

> *Taux résiduel de tacrolimus bas ; il avoue oublier la prise du soir.*

? Quelle hypothèse ?

REPÈRES ATTENDUS

- Non-observance aux immunosuppresseurs (fréquente chez le jeune adulte)
- Risque de rejet aigu ou chronique
- Autres causes : déshydratation, infection, obstacle
- Facteurs : transition, contraintes, effets indésirables

Raisonnement clinique · IPA MRC

♦ D

D ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Greffe : observance

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : Thomas, 23 ans, transplanté rénal à 18 ans, voit sa créatinine augmenter. Il fait ses études loin de chez ses parents.

> *Créatinine 160 µmol/L (valeur de base 110).*

? Quels examens ?

REPÈRES ATTENDUS

- Créatinine de contrôle, protéinurie, anticorps anti-HLA spécifiques du donneur
- Échographie du greffon
- Biopsie selon l'équipe de transplantation
- ECBU, taux de tacrolimus

Raisonnement clinique · IPA MRC

♣ D

D ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Greffe : observance

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : Thomas, 23 ans, transplanté rénal à 18 ans, voit sa créatinine augmenter. Il fait ses études loin de chez ses parents.

> *Thomas veut « garder son rein ».*

? Quel accompagnement proposez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Entretien motivationnel, sans jugement
- Forme à libération prolongée en une prise, si l'équipe la propose
- Alarmes, application, pilulier
- ETP transplantation, pairs aidants
- Suivi rapproché avec le centre de transplantation

Raisonnement clinique · IPA MRC

♠ D

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

R ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Greffe : prévention

Compétences IPA : C1

Mme G., 60 ans, transplantée rénale depuis 10 ans, vient pour son suivi annuel.

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Infections récentes, vaccinations
- Exposition solaire, lésions cutanées
- PA, poids, lipides, glycémie
- Dépistages des cancers
- Observance, effets indésirables

Raisonnement clinique · IPA MRC

R ♥

R ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Greffe : prévention

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : Mme G., 60 ans, transplantée rénale depuis 10 ans, vient pour son suivi annuel.

Elle jardine sans protection solaire ; lésion croûteuse sur le dos de la main.

? Quels risques identifiez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Cancers cutanés (carcinomes épidermoïdes) très augmentés sous immunosuppresseurs
- Lésion suspecte à examiner rapidement
- Risques infectieux et cardiovasculaire élevés
- Diabète post-transplantation

Raisonnement clinique · IPA MRC

R ♦

R ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Greffe : prévention

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : Mme G., 60 ans, transplantée rénale depuis 10 ans, vient pour son suivi annuel.

Vous complétez le bilan annuel.

? Quelles évaluations réalisez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Examen dermatologique complet annuel
- Dépistages des cancers adaptés
- HbA1c, lipides, PA
- Fonction du greffon, taux des immunosuppresseurs

Raisonnement clinique · IPA MRC

R ♣

R ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Greffe : prévention

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : Mme G., 60 ans, transplantée rénale depuis 10 ans, vient pour son suivi annuel.

Une consultation dermatologique est programmée.

? Quel plan de prévention ?

REPÈRES ATTENDUS

- Photoprotection : vêtements, chapeau, écran haute protection, éviter les heures chaudes
- Auto-examen de la peau
- Vaccinations à jour, pas de vaccin vivant ; entourage vacciné
- Prévention cardiovasculaire
- Coordination dermatologue, centre de transplantation, médecin traitant

Raisonnement clinique · IPA MRC

R ♠

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

A ♥

♥ CŒUR · RECUEILLIR

Traitement conservateur du sujet âgé

Compétences IPA : C1

M. V., 87 ans, MRC stade 5 (DFG 11), insuffisant cardiaque, vit en EHPAD. Le néphrologue propose de discuter des options.

? Quelles données recueillez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Fatigue, prurit, nausées, dyspnée, anorexie
- Autonomie, cognition, fragilité, comorbidités
- Souhaits, valeurs ; directives anticipées
- Entourage, personne de confiance
- Compréhension de la situation

Raisonnement clinique · IPA MRC

♥ A

A ♦

♦ CARREAU · REPÉRER & HYPOTHÈSES

Traitement conservateur du sujet âgé

Compétences IPA : C1 · C3

Situation : M. V., 87 ans, MRC stade 5 (DFG 11), insuffisant cardiaque, vit en EHPAD. Le néphrologue propose de discuter des options.

Il dit : « Je ne veux pas de machine. »

? Quels besoins identifiez-vous ?

REPÈRES ATTENDUS

- Traitement conservateur sans dialyse : un choix légitime à présenter
- Bénéfice incertain de la dialyse chez le sujet très âgé polypathologique
- Contrôle des symptômes
- Anticipation, soutien de l'entourage

Raisonnement clinique · IPA MRC

♦ A

A ♣

♣ TRÈFLE · VÉRIFIER

Traitement conservateur du sujet âgé

Compétences IPA : C1 · C2

Situation : M. V., 87 ans, MRC stade 5 (DFG 11), insuffisant cardiaque, vit en EHPAD. Le néphrologue propose de discuter des options.

Vous préparez la décision partagée.

? Quelles évaluations sont nécessaires ?

REPÈRES ATTENDUS

- Évaluation gériatrique standardisée
- Échelle de symptômes
- Capacité à décider
- Avis de l'équipe de l'EHPAD

Raisonnement clinique · IPA MRC

♣ A

A ♠

♠ PIQUE · AGIR & SUIVRE

Traitement conservateur du sujet âgé

Compétences IPA : C2 · C3 · C4

Situation : M. V., 87 ans, MRC stade 5 (DFG 11), insuffisant cardiaque, vit en EHPAD. Le néphrologue propose de discuter des options.

Le traitement conservateur est choisi.

? Comment organisez-vous le parcours ?

REPÈRES ATTENDUS

- Traitement conservateur actif : symptômes, anémie, équilibre hydrique
- Équipe de soins palliatifs, prescriptions anticipées
- Directives anticipées et personne de confiance formalisées
- Coordination néphrologue, médecin coordonnateur, équipe de l'EHPAD
- Réévaluation régulière, soutien de la famille

Raisonnement clinique · IPA MRC

♠ A

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

JOKER

JOKER 1

Drapeau rouge

Choisissez une situation du jeu et citez au moins deux signes d'alerte qui imposent une orientation urgente.

Si le groupe valide, ce joker remplace n'importe quelle carte manquante d'un carré.

JOKER

JOKER

JOKER 2

Leadership & recherche

À partir de la dernière situation jouée, proposez une action d'amélioration des pratiques (protocole, audit, formation) ou formulez une question de recherche (PICO).

Compétences C5 · C6. Si le groupe valide, ce joker remplace une carte manquante d'un carré.

JOKER

Aide-mémoire · les couleurs

Chaque couleur est une étape du raisonnement.

♥ **Cœur · Recueillir**
Anamnèse, écoute, contexte de vie

♦ **Carreau · Repérer & hypothèses**
Repérage, scores, hypothèses et drapeaux rouges

♣ **Trèfle · Vérifier**
Examen clinique, examens complémentaires, diagnostics différentiels

♠ **Pique · Agir & suivre**
Projet de soins, prévention, ETP, parcours et coordination

Un **carré** (les 4 couleurs d'une même valeur) = un raisonnement complet sur un même patient.

Aide-mémoire · les thématiques

Chaque valeur suit un même patient à travers les 4 étapes.

2	Repérage de la MRC
3	Néphroprotection et iatrogénie
4	Hyperkaliémie
5	Anémie de la MRC
6	Troubles minéraux et osseux
7	Nutrition et MRC
8	Choix du traitement de suppléance
9	Fistule artério-veineuse
10	Hémodialyse : surcharge hydrosodée
V	Dialyse péritonéale : péritonite
D	Greffe : observance
R	Greffe : prévention
A	Traitement conservateur du sujet âgé

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master

♥ ♦ ♣ ♠

Raisonnement clinique

IPA · MRC

IPA · Master